

Introduction

La listériose est une maladie grave pouvant se manifester par des formes invasives, notamment des bactériémies et des infections du système nerveux central. La majorité des cas de méningites sont associés à une encéphalite.

L'homme s'infecte par voie digestive en ingérant le plus souvent du lait ou du fromage non ou mal pasteurisé, ou de la charcuterie industrielle.

En dehors de la période néonatale, une méningite à *L.monocytogenes* est rare chez le sujet immunocompétent, avec pour conséquence un retard de diagnostic et de traitement.

La prise en charge d'une méningite à *L.monocytogenes* est une urgence diagnostique et thérapeutique.

Objectifs

Souligner l'importance de rechercher *L.monocytogenes* comme étiologie d'une méningite en dehors de tout contexte de trouble de l'immunité.

Montrer l'intérêt de la biologie moléculaire, notamment la PCR multiplex, dans le diagnostic rapide d'une méningite à *L.monocytogenes*.

Rappeler l'importance d'une antibiothérapie adaptée, notamment en raison de sa résistance naturelle aux céphalosporines.

Matériel et méthodes

Nous rapportons le cas d'un homme âgé de 28ans, sans antécédent notable, hospitalisé pour un syndrome méningé fébrile.

Le patient était sous ceftriaxone injectable.

Les examens microbiologiques réalisés comprenaient l'ECB du LCS, une identification par système automatisé Vitek, ainsi qu'une PCR multiplex.

Résultats

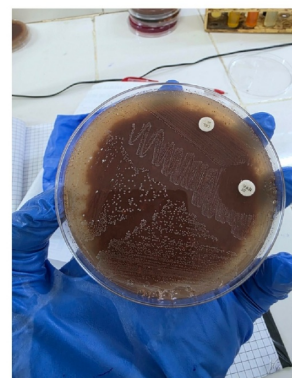
L'étude du LCS montre une hypercellularité à 750 éléments/mm³, dont 80% lymphocytes, et 20% polynucléaire.

Après 24h d'incubation en aérobiose à 37 °C sur gélose chocolat, de petites colonies lisses à bords réguliers bêta hémolytiques sont observées.

L'examen microscopique met en évidence de petits bacilles ou coccobacilles à Gram positif, disposés en paires ou en courtes chaînettes. Après culture en milieu liquide, les bacilles sont plus longs et disposés en palissade.

Les bactéries sont mobiles à température ambiante (22 - 25°C) présentant un mouvement en rotation ou en ombrelle, et immobiles à 37 °C.

Les caractères biochimiques (vitek et galerie classique) : Catalase (+), Hydrolyse de l'esculine (+), VP (+), glucose (+), mannitol (-), urée (-).



Conclusion

La méningite à *L.monocytogenes* est une infection rare mais potentiellement grave qui peut exceptionnellement toucher un sujet jeune et apparemment immunocompétent.

Il ne faut pas l'ignorer dans le processus diagnostique et thérapeutique des méningites et des méningo-encéphalites à prédominance lymphocytaires de l'immunocompétent.

L'identification rapide de *L.monocytogenes* est essentielle car ce germe présente une résistance naturelle aux céphalosporines. Une antibiothérapie adaptée, reposant notamment sur l'amoxicilline, doit donc être instaurée dès que le diagnostic est suspecté ou confirmé.

Le diagnostic d'une méningite à *L.monocytogenes* repose classiquement sur l'examen direct et la culture du LCS, mais les techniques moléculaires, notamment la PCR multiplex, peuvent permettre une identification plus rapide.

Mots clés

Méningite; *Listeria monocytogenes*; immunocompétent